

# Spolupráca všeobecného lekára a nefrológa pri CKD G5: poučenie zo štúdie JOINT-KD

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 10.10.2026



Ilustračná scéna. Ani jedna zo strán nestačí sama; v pokročilom štádiu rozhoduje, či starostlivosť pokračuje spoločne.

Manažment pacienta s chronickou chorobou obličiek v štádiu G5 nie je iba otázkou rozhodnutia, kedy začať dialýzu. Ide o komplexnú starostlivosť o človeka s vysokým rizikom hospitalizácie, infekcií, kardiovaskulárnych komplikácií, nutričných problémov, polyfarmácie, krehkosti a zhoršenej kvality života.

Štúdia JOINT-KD publikovaná v *Journal of Nephrology* sa venovala prakticky dôležitej otázke: má spolupráca medzi lekárom primárnej starostlivosti a nefrológom merateľný klinický prínos u pacientov s CKD v štádiu G5?

Citovaný zdroj je formálne oprava článku, publikovaná v roku 2026. Pôvodný článok vyšiel v roku 2025 a obsahuje hlavné klinické výsledky, z ktorých tento text vychádza. Oprava sa týka rozšírenia etickej deklarácie a nemení interpretáciu hlavných klinických výsledkov.

## Prečo je táto téma dôležitá

Pacienti s CKD G5 sú často sledovaní nefrológom, ale ich zdravotný stav presahuje rámec jednej špecializácie. Mávajú diabetes, hypertenziu, srdcové zlyhávanie, anémiu, poruchy minerálového metabolizmu, infekčné komplikácie, krehkosť, sociálne problémy a vysokú liekovú záťaž.

Všeobecný lekár alebo lekár primárnej starostlivosti tu môže zohrať významnú úlohu. Často je bližšie k pacientovi, pozná jeho domáce a sociálne zázemie, rieši akútne ťažkosti medzi nefrologickými kontrolami a môže včas zachytiť zhoršenie celkového stavu.

Primárna starostlivosť môže pomáhať najmä pri prevencii a skorom zachytení infekcií, očkovaní, sledovaní komorbidít, koordinácii liekov, prevencii polyfarmácie a rozhodovaní, kedy je potrebné kontaktovať nefrológa alebo odoslať pacienta na urgentné vyšetrenie.

## Dizajn štúdie

Autori vykonali retrospektívnu kohortovú štúdiu u dospelých ambulantných pacientov s CKD v štádiu G5 sledovaných v deviatich nefrologických centrách v Japonsku.

Hlavným sledovaným faktorom bola spolupráca lekára primárnej starostlivosti s nefrológom. Autori porovnávali pacientov manažovaných v spolupráci primárneho lekára a nefrológa s pacientmi sledovanými iba nefrológom.

Hodnotené boli najmä začatie dialýzy, hospitalizácie súvisiace s CKD, kardiovaskulárne hospitalizácie a hospitalizácie pre infekcie. Pri analýze boli použité modely zohľadňujúce konkurenčné riziká, napríklad úmrtie alebo preemtívnu transplantáciu obličky.

## Charakteristika súboru

Do analýzy bolo zahrnutých 570 pacientov s CKD G5. Z nich 91 pacientov, teda 16,0 %, malo spoluprácu medzi lekárom primárnej starostlivosti a nefrológom. Ostatní pacienti boli sledovaní nefrológom bez takejto formálnej spolupráce.

Medián sledovania bol 1,4 roka. Počas sledovania 399 pacientov, teda 70,0 %, začalo dialýzu. Preemtívnu transplantáciu obličky podstúpilo 11 pacientov, teda 1,9 %, a 53 pacientov, teda 9,3 %, zomrelo.

Ide teda o populáciu s veľmi pokročilým ochorením obličiek, v ktorej je prirodzene vysoká pravdepodobnosť začatia náhrady funkcie obličiek alebo závažných klinických udalostí.

## Hlavné výsledky

Spolupráca primárneho lekára a nefrológa nebola spojená s oddialením začatia dialýzy. Upravený pomer subdistribučných rizík (subdistribution hazard ratio) bol 0,89 (95 % interval spoľahlivosti 0,64 až 1,23).

Podobne nebol zistený významný rozdiel pri hospitalizáciách súvisiacich s CKD ani pri kardiovaskulárnych hospitalizáciách.

Významný rozdiel sa však ukázal pri hospitalizáciách pre infekcie. Spolupráca lekára primárnej starostlivosti a nefrológa bola spojená s nižším rizikom infekčnej hospitalizácie. Upravený pomer subdistribučných rizík bol 0,36 (95 % interval spoľahlivosti 0,15 až 0,87). Ide o observačné zistenie, klinický signál je však relevantný.

## Klinická interpretácia

Výsledok je zaujímavý práve preto, že spolupráca primárnej a špecializovanej starostlivosti nezmenila všetky sledované ukazovatele. Neoddialila dialýzu a nepreukázala jasný vplyv na kardiovaskulárne hospitalizácie. Jej prínos sa však prejavil v oblasti infekcií.

Klinicky je to pochopiteľné. Infekčné komplikácie u pacientov s pokročilou CKD často začínajú ako zdanlivo bežné ambulantné problémy: infekcia močových ciest, pneumónia, kožná infekcia, respiračné ochorenie, febrilita, dehydratácia alebo nešpecifické zhoršenie celkového stavu.

Ak je pacient zachytený skoro, môže sa znížiť riziko ťažkého priebehu a potreby hospitalizácie. Lekár primárnej starostlivosti môže v tomto smere dopĺňať nefrológa, pretože je pre pacienta často dostupnejší medzi špecializovanými kontrolami.

## Primárna starostlivosť nenahrádza nefrológa

Výsledok nie je argumentom za presun pokročilej CKD do primárnej starostlivosti. Pacient s CKD G5 potrebuje nefrologické vedenie: prípravu na dialýzu alebo transplantáciu, manažment anémie, poruchy minerálovo-kostného metabolizmu, metabolickej acidózy, hyperkaliémie, objemu a antihypertenzívnej liečby.

Prínos spolupráce pravdepodobne vzniká vtedy, keď sa obe úrovne starostlivosti dopĺňajú. Nefrológ riadi obličkové ochorenie a prípravu na náhradu funkcie obličiek. Primárny lekár pomáha so skorým zachytením infekcií, komorbiditami, očkovaním, liekovou bezpečnosťou a kontinuálnym kontaktom s pacientom.

Podstatné nie je, že pacient má „viac lekárov“, ale že má koordinovaný plán a každý člen tímu vie, čo má sledovať a kedy má reagovať.

## Infekcie ako slabé miesto CKD G5

Pacienti s pokročilou CKD majú zvýšené riziko infekcií z viacerých dôvodov. Patrí k nim porucha imunity spojená s urémiou, vyšší vek, diabetes, malnutícia, anémia, opakované kontakty so zdravotníckym systémom a často aj budúca potreba cievneho prístupu alebo dialýzy.

Infekčná hospitalizácia pritom nie je banálna epizóda. U pacienta s CKD G5 môže viesť k akcelerácii poklesu renálnej funkcie, urgentnému začatiu dialýzy, delíriu, poklesu funkčnej kapacity, kardiovaskulárnym komplikáciám a zvýšenej mortalite.

Ak koordinovaná starostlivosť znižuje riziko infekčných hospitalizácií, ide o klinicky relevantný prínos aj vtedy, keď neovplyvní samotný čas začatia dialýzy.

## Význam pre nefrologickú prax

Pre nefrológa z toho vyplýva praktický záver: pacient s CKD G5 by nemal byť izolovaný iba v špecializovanej nefrologickej ambulancii. Aj pri pokročilom ochorení obličiek má zmysel koordinovaná spolupráca s primárnou starostlivosťou.

Takýto model môže byť dôležitý najmä u pacientov vo vyššom veku, s viacerými komorbiditami, častými infekciami, sociálnou alebo logistickou bariérou dostupnosti nefrológa, polyfarmáciou, krehkosťou alebo v období prípravy na dialýzu.

Kľúčové je jasné rozdelenie kompetencií. Primárny lekár má vedieť, kedy pacienta riešiť ambulantne, kedy kontaktovať nefrológa a kedy pacienta odoslať na urgentné vyšetrenie. Nefrológ má poskytnúť zrozumiteľný plán starostlivosti vrátane cieľových hodnôt, varovných príznakov, úpravy liekov a plánu prípravy na dialýzu alebo transplantáciu.

## Praktická organizácia spolupráce

Zo štúdie nemožno priamo odvodiť univerzálny model pre všetky zdravotnícke systémy, ale pre prax sú rozumné tieto princípy:

- pacient s CKD G5 má mať jasne definovaného nefrológa aj lekára primárnej starostlivosti,
- medzi lekármi má byť zdieľaný plán sledovania a liečby,
- treba aktívne riešiť očkovanie, infekčné riziká a skoré príznaky infekcie,
- liekové zmeny majú zohľadňovať aktuálnu eGFR, hyperkaliémiu, objemový stav a riziko nefrotoxicity,
- pacient má vedieť, koho kontaktovať pri horúčke, dyspnoe, zhoršení diurézy, edémoch, slabosti alebo známkach infekcie,
- príprava na dialýzu má byť koordinovaná včas, nie až pri urgentnej dekompenzácii.

V slovenskej praxi môže byť dôležitá aj dostupnosť nefrologickej ambulancie, vzdialenosť pacienta, kapacita primárnej starostlivosti a kvalita komunikácie cez výmenné lístky, elektronickú dokumentáciu alebo priame konzultácie.

## Čo má obsahovať zdieľaný plán

Pri CKD G5 by zdieľaný plán nemal byť len všeobecnou poznámkou, že pacient je sledovaný nefrológom. Prakticky má obsahovať:

1. **Aktuálny nefrologický stav.** eGFR alebo kreatinín, trend, albuminúria alebo proteinúria, komplikácie CKD a plán náhrady funkcie obličiek.
2. **Lieky a riziká.** Čo neupravovať bez konzultácie, ktoré lieky sú rizikové pri zhoršení stavu a aké sú limity pre draslík, tlak alebo objem.
3. **Varovné príznaky.** Horúčka, dyspnoe, zmätenosť, oligúria, rýchly nárast edémov, hypotenzia, hyperkaliemické príznaky alebo známky infekcie.
4. **Kontakt a eskalácia.** Kedy volať nefrológa, kedy poslať pacienta na urgentný príjem a kedy stačí ambulantná kontrola.
5. **Prevencia.** Očkovanie, nutričné odporúčania, prevencia pádov, infekčná prevencia a plán kontroly komorbidít.

## Limity štúdie

Štúdia bola retrospektívna a observačná. Preto nemožno s istotou tvrdiť, že samotná spolupráca primárneho lekára a nefrológa spôsobila nižšie riziko infekčných hospitalizácií. Môžu existovať rozdiely medzi pacientmi, ktorí takúto spoluprácu mali, a tými, ktorí boli sledovaní iba nefrológom.

Sledovanie bolo relatívne krátke, s mediánom 1,4 roka. Výsledky pochádzajú z japonského zdravotníckeho systému, ktorý sa môže líšiť od európskej alebo slovenskej organizácie starostlivosti.

Napriek týmto limitom je štúdia cenná, pretože sa venuje veľmi praktickej otázke organizácie starostlivosti o pacientov s najpokročilejšou CKD pred začatím dialýzy.

## Záver

Štúdia JOINT-KD ukazuje, že spolupráca medzi lekárom primárnej starostlivosti a nefrológom u pacientov s CKD G5 pravdepodobne nevedie k oddialeniu dialýzy, ale môže byť spojená s nižším rizikom hospitalizácie pre infekcie.

Kvalitná starostlivosť o pacienta s pokročilou CKD nie je iba otázkou nefrologickej expertízy, ale aj dobrej koordinácie, dostupnosti, prevencie a včasného zachytenia komplikácií.

Najmä infekcie predstavujú oblasť, kde môže primárna starostlivosť v spolupráci s nefrológom priniesť reálny prínos. Cieľom nemá byť presun zodpovednosti, ale spoločný plán, ktorý pacienta zachytí skôr, než sa ambulantný problém zmení na hospitalizáciu.

---

**Zdroj:** Murakami M, Aoki T, Sugiyama Y, Sasaki S, Nishiwaki H, Yazawa M, Raita Y, Kawarazaki H, Shimizu H, Nakamura Y, Saka Y, Matsushima M. Association between primary care physician-nephrologist collaboration and clinical outcomes in patients with stage 5 chronic kidney disease: a JOINT-KD cohort study. *Journal of Nephrology*. 2025;38(5):1385-1394. doi:10.1007/s40620-025-02299-1. PMID: 40338420. [PubMed](#).

**Oprava zdroja:** Correction to: Association between primary care physician-nephrologist collaboration and clinical outcomes in patients with stage 5 chronic kidney disease: a JOINT-KD cohort study. *Journal of Nephrology*. Publikované online 26. júna 2026; aajag167. doi:10.1093/joneph/aajag167. PMID: 42360783. [Oxford Academic](#); [PubMed](#).

---

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=spolupraca-vseobecny-lekar-nefrolog-ckd-g5-joint-kd> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.